แพทยศาสตร์ • บทความวิชาการ

การสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ

การอธิบายความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน

กองบรรณาธิการ ราชบัณฑิตยสภา
สำนักวิทยาศาสตร์

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๙ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ อ่าน ๗ นาที

ความนำ

ข้อมูลด้านสุขภาพแทบทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นโอกาสเกิดโรค ผลข้างเคียงของยา หรือประโยชน์ของการตรวจคัดกรอง การสื่อสารความเสี่ยง (risk communication) คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน และประชาชน เพื่อให้แต่ละคนตัดสินใจเรื่องสุขภาพได้อย่างมีข้อมูล บทความนี้สรุปหลักพื้นฐานของการอธิบายความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอย่างตรงไปตรงมา

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

ความเสี่ยง หมายถึงโอกาสที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จะเกิดขึ้น ร่วมกับความรุนแรงของผลที่ตามมา ส่วน ความไม่แน่นอน หมายถึงขอบเขตของสิ่งที่ยังไม่รู้หรือยังรู้ไม่ครบ เช่น ข้อมูลยังมีน้อย หรือผลการศึกษายังไม่สอดคล้องกัน ทั้งสองเรื่องนี้ต่างกัน และควรอธิบายแยกกันให้ชัด เพราะผู้ฟังอาจเข้าใจว่าความไม่แน่นอนแปลว่าผู้เชี่ยวชาญไม่มีความรู้ ทั้งที่ความไม่แน่นอนเป็นลักษณะปกติของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ยังพัฒนาอยู่

การนำเสนอตัวเลขให้เข้าใจง่าย

วิธีนำเสนอตัวเลขมีผลอย่างมากต่อการรับรู้ของผู้ฟัง
ตัวอย่างสมมุติต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลชุดเดียวกันอาจฟังดูต่างกันได้

วิธีนำเสนอ	ตัวอย่างข้อความ
ความเสี่ยงสัมพัทธ์ (relative risk)	การปฏิบัติตัวแบบนี้ช่วยลดความเสี่ยงได้ครึ่งหนึ่ง
ความเสี่ยงสัมบูรณ์ (absolute risk)	จากผู้คน ๑,๐๐๐ คน จำนวนผู้ที่เกิดโรคลดลงจาก ๒ คน เหลือ ๑ คน

ข้อความแรกฟังดูน่าประทับใจกว่า แต่ข้อความที่สองช่วยให้ผู้ฟังเห็นขนาดของประโยชน์ที่แท้จริง
แนวทางที่นิยมใช้คือ

- แสดงความเสี่ยงสัมบูรณ์ทุกครั้ง หากจะกล่าวถึงความเสี่ยงสัมพัทธ์ควรแสดงคู่กัน
- ใช้ความถี่ เช่น ๑ ใน ๑,๐๐๐ คน แทนร้อยละที่มีทศนิยมหลายตำแหน่ง
- ใช้ฐานตัวเลขเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบหลายทางเลือก
- บอกกรอบเวลา เช่น ภายใน ๕ ปี หรือตลอดช่วงชีวิต

การยอมรับสิ่งที่ยังไม่รู้

ในสถานการณ์ที่ข้อมูลยังเปลี่ยนแปลง เช่น ช่วงเริ่มต้นของการระบาดของโรคอุบัติใหม่
ผู้สื่อสารควรบอกให้ชัดว่าอะไรที่รู้แล้ว อะไรที่ยังไม่รู้ และกำลังดำเนินการอะไรเพื่อหาคำตอบ
พร้อมแจ้งล่วงหน้าว่าคำแนะนำอาจปรับเปลี่ยนเมื่อมีข้อมูลใหม่
การทำเช่นนี้ช่วยรักษาความน่าเชื่อถือได้ดีกว่าการให้คำมั่นที่อาจต้องถอนคืนในภายหลัง

> การบอกว่ายังไม่รู้ พร้อมอธิบายว่าจะหาคำตอบอย่างไร ไม่ได้ทำให้ผู้สื่อสารดูอ่อนแอ
> แต่ทำให้ผู้ฟังไว้วางใจมากขึ้น

การสื่อสารสองทาง

การสื่อสารความเสี่ยงที่ดีไม่ใช่การประกาศข้อมูลทางเดียว หน่วยงานควรรับฟังความกังวลของประชาชน ทำความเข้าใจว่าคนในพื้นที่รับรู้ปัญหาอย่างไร และตอบคำถามที่เกิดขึ้นจริง
ข้อความควรใช้ภาษาที่กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ คำนึงถึงผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการได้ยิน และผู้ที่ใช้ภาษาอื่น นอกจากนี้ควรบอกสิ่งที่ผู้ฟังทำได้ เพื่อให้ข้อมูลความเสี่ยงนำไปสู่การปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงความกังวล

ข้อมูลความเสี่ยงในระดับประชากรอาจไม่ตรงกับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองควรปรึกษาแพทย์

สรุป

การสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างตรงไปตรงมา ประกอบด้วยการนำเสนอตัวเลขในรูปที่เข้าใจง่าย การแยกความเสี่ยงออกจากความไม่แน่นอน การยอมรับสิ่งที่ยังไม่รู้ และการเปิดให้ประชาชนซักถาม หลักเหล่านี้ช่วยให้ผู้รับข้อมูลตัดสินใจได้ด้วยตนเองและไว้วางใจแหล่งข้อมูลในระยะยาว

เอกสารอ้างอิง

1. องค์การอนามัยโลก (World Health Organization). *Risk communications*. https://www.who.int/emergencies/risk-communications
2. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. https://ddc.moph.go.th/
3. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. *ระบบศัพท์บัญญัติ*. https://coined-word.orst.go.th/

อ้างอิงบทความนี้

APA MLA Chicago

กองบรรณาธิการ ราชบัณฑิตยสภา. (๒๕๖๙, ๑๙ มีนาคม). *การสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ*. ราชบัณฑิตยสภา. https://royalsociety.go.th/pages/article.html?id=kn-medicine-๒๐๒๖-๐๓-๑๙

คัดลอกการอ้างอิง